



LA CONTRACEPTION

FACULTÉ DE MÉDECINE
CHU DJILLALI BOUNAAMA DOUERA
MODULE DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
DR H.ZOUAOUI

PLAN:

- Introduction
- Définition
- Contraception hormonale
- Contraception mécanique
- Méthodes dites « naturelles »
- Contraceptions d'urgence
- Contraception définitive : stérilisation
- Contraception masculine

INTRODUCTION

Le rôle du médecin est principalement:

- ✓ d'informer le couple sur les avantages, les inconvénients et les échecs de la méthode retenue,
- ✓ d'éliminer les contre-indications éventuelles et de proposer le produit le plus adapté à la patiente.

DÉFINITION

Tout procédé empêchant la conception de manière temporaire et réversible et permettant une activité sexuelle normale.

Doit répondre à 04 impératifs :

- ✓ totale efficacité: évaluée par l'indice de PEARL
- ✓ bonne acceptabilité
- ✓ réversibilité
- ✓ innocuité parfaite

L'INDICE DE PEARL

- **IP (%) = [(nombre de grossesses non planifiées/nombre de mois d'utilisation d'une méthode contraceptive) × 1 200]/100**
- À titre d'exemple, P = 2 veut dire que 2 femmes sur 100 soumises à la méthode pendant 1 an ont été enceintes au cours de cette période d'exposition
- Une contraception est jugée réellement efficace en dessous de 5%

CONDITIONS POUR AVOIR UNE GROSSESSE:

Pour qu'il y ait une grossesse, 3 conditions sont requises :

L'ovulation

le développement des follicules donne un follicule mûr qui va expulser un ovule à chaque cycle menstruel.

La fécondation

grâce à une glaire cervicale filante les spermatozoïdes vont passer le col de l'utérus pour rencontrer l'ovule et le féconder.

La nidation

l'embryon issu de la fécondation va migrer dans l'utérus et s'implanter dans l'endomètre pour poursuivre son développement.

MÉTHODES CONTRACEPTIVE

Contraception hormonale

oestro-progestative: (pilule, patch, anneau vaginal)

progestative seul: (pilule micro ou macro-dosée, contraception injectable, implant, stérilet à la progestérone)

Contraception mécanique

stérilet, diaphragme, spermicides, préservatifs (masculins et féminins)

Méthodes dites « naturelles »

Contraceptions d'urgence

hormonale ou dispositif intra-utérin

Contraception définitive

stérilisation tubaire, vasectomie

Contraception masculine

PRINCIPAUX MODE DE CONTRACEPTION



Contraception hormonale

1. Contraception œstroprogestative

- Pilule :
 - en schéma 21 jours
 - en schéma continu
- Anneau intra-vaginal
- Patch contraceptif (transdermique)

2. Contraception progestative

- Pilule
- Implant (sous cutané)
- Stérilet hormonal (dispositif intra utérin)



Contraception non hormonale

3. Contraception non hormonale

- Stérilet au cuivre (dispositif intra utérin)
- Diaphragme, capes cervicales
- Spermicides
- préservatifs (masculins et féminins)

CONTRACEPTION OESTRO- PROGESTATIVE

- Pilule oestro-progestative
- Patch contraceptif
- L'anneau vaginal

MODE D'ACTION

03 verrous de sécurité :

- Inhibition de la sécrétion hypophysaire (FSH.LH) → inhibition de l'ovulation (l'action antigonadotrope).
- Inhibition de la prolifération endométriale (impropre à la nidation)
- Modification de la glaire cervicale (rareté et épaissement) empêchant la pénétration et l'ascension des spz.

LES PRODUITS UTILISÉS

Œstrogènes

- l'ethinyl-oestradiol (EE)

il a une meilleure biodisponibilité, mais avec une forte affinité pour le foie qui peut induire des effets secondaires métaboliques et vasculaires plus importantes.

- Valérate d'Estradiol VE

œstrogène naturel, moins d'effets secondaires, non disponible.

Selon le dosage de l'EE

- Les pilules normo-dosées 50 µg d'EE /cp

- Les pilules minidosées 15-20-30-35-40 µg d'EE /cp.

LES PRODUITS UTILISÉS

Progestatifs

ce sont des progestatifs de synthèses, ils sont dotés d'une activité anti-gonadotrope très supérieure à celle de la progestérone naturelle qui justifie leur emploi en contraception.

On distingue :

- ✓ Progestatifs de 1ère génération effets androgéniques ++
- ✓ Progestatifs de 2e génération Lévonogestrel
- ✓ Progestatifs de 3e génération faible effet androgénique et moins d'effets secondaires (Desogestrel, Gestodène, Norgestimate)
- ✓ Progestatifs de 4e génération Drospirènone, Dienogest

LES DIFFÉRENTES PILULES OESTRO-PROGESTATIVES

Selon la répartition des variations du dosage de l'EE et du progestatif utilisés durant la plaquette, on distingue

- Des pilules séquentielles où le progestatif n'apparaît que pendant la 2ème partie du cycle. Il s'agit de pilules plutôt thérapeutiques pour faire régénérer l'endomètre abrasé (curetage) ou atrophique.
- Des pilules combinées où le progestatif est associé tout au long du cycle, ce qui procure une parfaite efficacité

EXEMPLE DE PILULES COMBINÉES

Normodosés contenant 50 γ d'EE (Stederil, Néogynon)

Minidosés contenant 30 à 40 γ d'EE:

Minidosée monophasique : EE et P à la même dose durant toute la durée de la plaquette (Microgynon)

Minidosée biphasique : variant selon 2 paliers (Adépal)

Minidosée triphasique : variant selon 3 paliers (Triella, Logynon)

OP à 20 γ d'EE (Mercilon, Méliane).

OP à 15 γ d'EE (Miness)

COMMENT PRENDRE SA PILULE?!

- ✓ Prise du premier comprimé de la plaquette le premier jour des règles lorsque la patiente n'était pas sous OP et au plus tard le 5ème jour.
- ✓ Pour les plaquettes à 21 cp, il faut un arrêt systématique de 07jours



Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
Arrêt						
29	30	31	1	2	3	4

1 cycle

Début du cycle suivant

COMMENT PRENDRE SA PILULE?!

- Pour les plaquettes à 28 cp le traitement sera continu (7cp placebo)
Prise journalière au même moment, il faut respecter l'ordre des comprimés.



- **Avantage** : évite d'oublier
de reprendre sa pilule
après le semaine d'arrêt

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI DE PILULE ?

- si oubli date de moins de 12h = prendre le comprimé et continuer la plaquette normalement
- Si l'oubli date de plus de 12h = prendre le comprimé oublié dès que vous constatez l'oubli et le comprimé du jour comme d'habitude puis continuez votre plaquette normalement jusqu'à la fin du cycle.
- Utilisez en plus une méthode de contraception locale jusqu'à la fin de la plaquette.

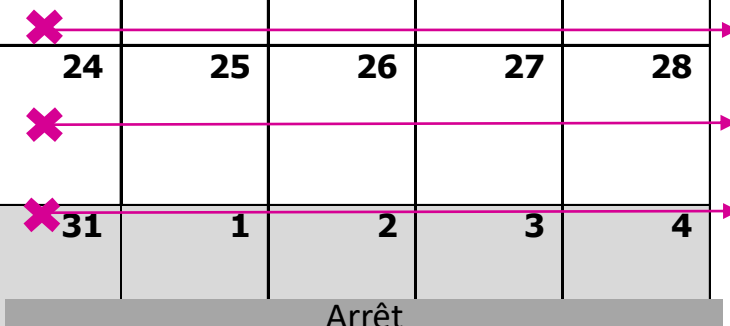
B-Patch



PRINCIPE DU PATCH CONTRACEPTIF

- Diffuse quotidiennement et de façon continue 20 µg d'éthinylestradiol et 150 µg de norelgestromine
- Le principal mode d'action du timbre est de prévenir l'ovulation en inhibant la sécrétion des gonadotrophines. Il peut également épaissir le mucus cervical, causer l'atrophie de l'endomètre et possiblement altérer le transport tubaire.
- Voie d'administration : voie transdermique.
- Mode d'utilisation: coller 1 patch par semaine pendant 3 semaines, suivies d'1 semaine d'arrêt.

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4



1 cycle = 28 jours

← Début du cycle suivant

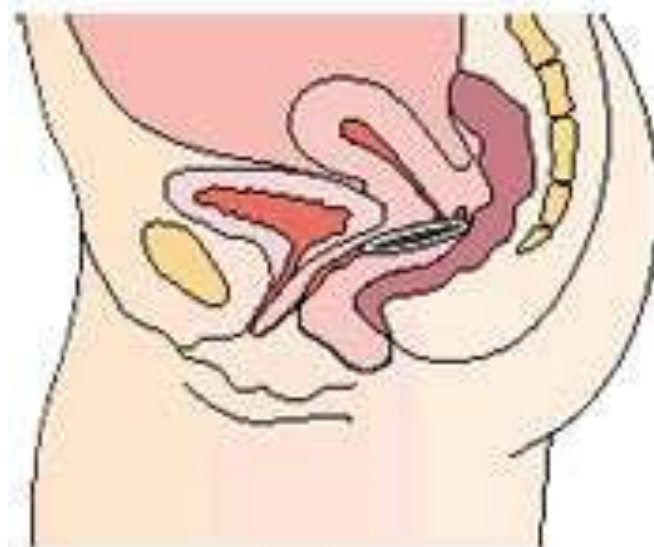
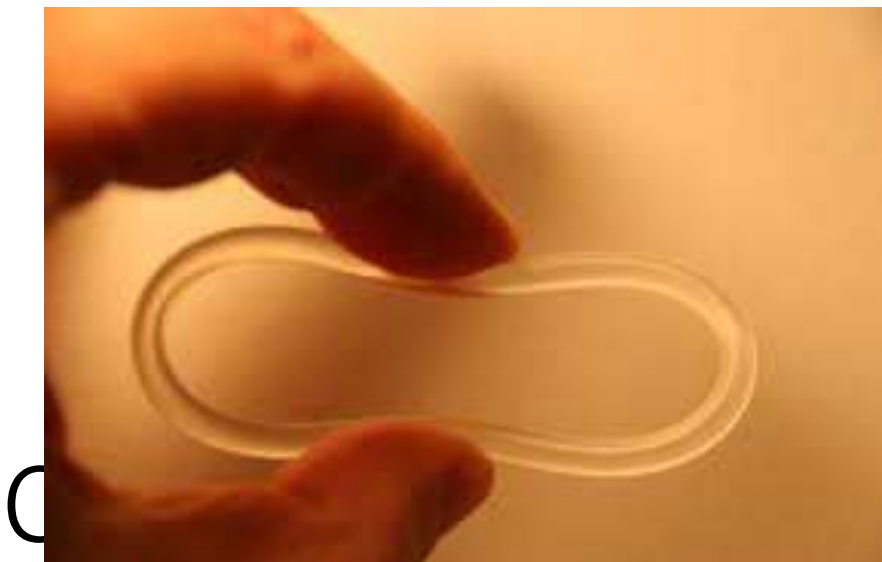
PATCH CONTRACEPTIF

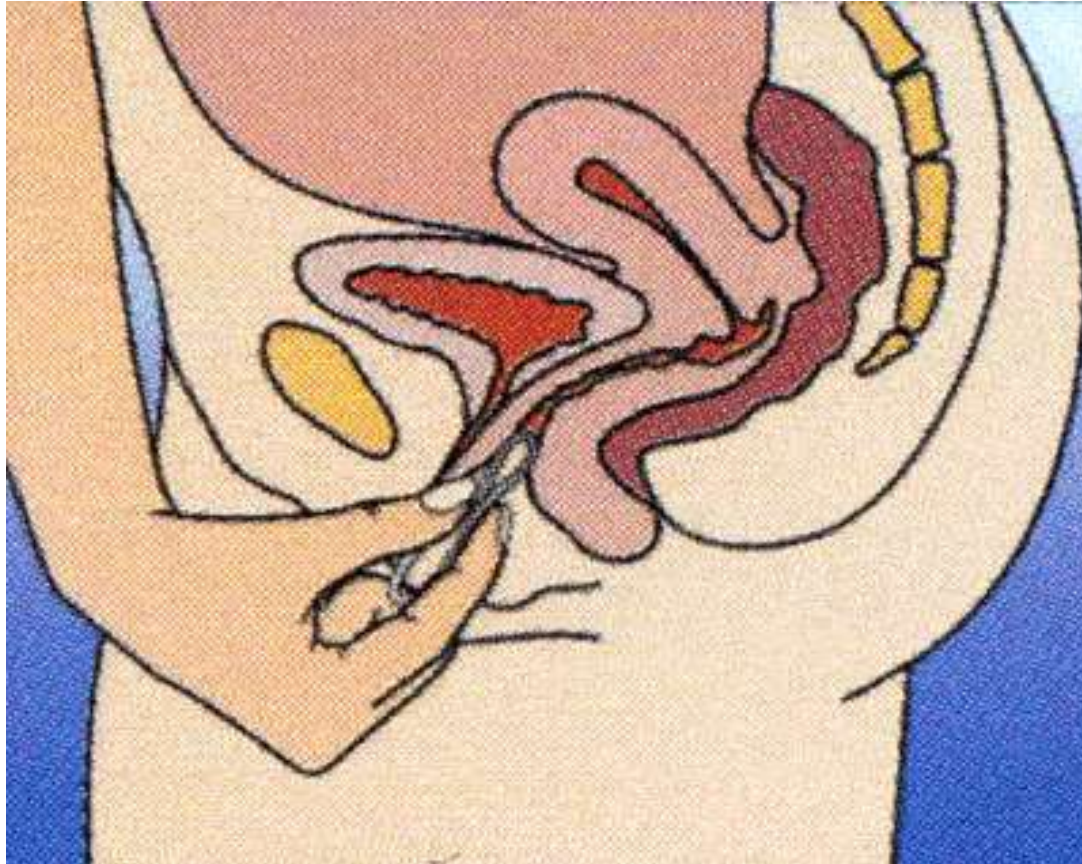
- Efficacité contraceptive comparable à la pilule
- Facile à poser
- 4 sites d'application possibles (ne pas appliquer sur les seins) :
 - ✓ fesse,
 - ✓ abdomen,
 - ✓ partie supérieure du dos,
 - ✓ face externe du bras.
- Reste en place quelque soit les situations (Testé dans situations extrêmes : piscine, sauna, sport, douche...)



L'ANNEAU VAGINAL

- C'est un contraceptif hormonal combiné puisqu'il contient un oestrogène(éthinyloestradiol) et un progestatif(étonogestrel) qu'il libère lentement et de façon continue via l'épithélium vaginal pendant une période de trois semaines.
- Mode d'utilisation : insérer profondément au fond du vagin 1 anneau intra-vaginal pendant 3 semaines suivies d'1 semaine d'arrêt.





LA SURVEILLANCE

Surveillance clinique et biologique

une consultation tout les trois mois s'impose elle comprend un examen clinique génital, mammaire.

La surveillance ultérieure s'effectue tout les 6 ou 12 mois avec un FCV/ 3 ans et un bilan biologique / an

EFFETS SECONDAIRES

Imputables pour la majorité à la composante oestrogénique

- **Métabolisme lipidique** élévation des TG, HDL cholestérol
- **Métabolisme glucidique** diminution de la tolérance aux hydrates de carbone. Diabétogène chez les sujets prédisposés.
- **Effet sur la TA** augmente les chiffres tensionnels et dans 5% des cas HTA réelle (par altération des parois vasculaires) .
- **Effet sur les facteurs de coagulation** hypercoagulabilité
- **Risque thromboembolique** plus marqué chez les femmes de plus de 35 ans, fumeuses, ayant pris la pilule pendant plus de 5 ans.
- **Risque hépatobiliaire** (ictère cholestatique, lithiase cholestérolique)
- **Autres** Spotting, acné, un hirsutisme, douleurs pelviennes, prise de poids, la diminution de la libido.

LES CONTRE-INDICATIONS

Les contre-indications relatives :

- ✓ Allaitement
- ✓ Age > 40 ans
- ✓ Obésité
- ✓ Migraine
- ✓ Varices importantes
- ✓ Tabac (< 15 cig/jour)
- ✓ diabète insulino-dépendant,
- ✓ Antécédents familiaux de cancer du sein,
- ✓ Allaitement prolongé

LES CONTRE-INDICATIONS **ABSOLUES** :

- ATCD thromboembolique artériel et/ ou veineux
- Cardiopathies thrombogènes, HTA chronique
- Fumeuse de plus de 35 ans (> 15 cig/j)
- Pathologies cérébrales d'origine vasculaire
- Hémopathies sévères et récentes
- la prise concomitante de tuberculostatiques, d'anticonvulsivants inducteurs enzymatiques
- ATCD de prurit et de cholestase gravidique
- Insuffisance hépatique, adénome du foie
- Hépatite virale en cours
- Diabète mal équilibré - Hyperlipidémie
- Cancer du sein et de l'utérus
- Thrombophilie connue, lupus

La contraception progestative **pure**

- ✓ Pilule micro dosée ou micropilule
- ✓ La contraception macroprogestative
- ✓ les progestatifs administrés par de nouvelles voies

Mode d'action

- Atrophie de l'endomètre : action anti-nidatoire
- Modification de la glaire cervicale qui devienne imperméable aux SPZ.
- Action anti-gonadotrope: (pas toutes)
- Ralentissement de la mobilité tubaire

LA CONTRACEPTION PROGESTATIVE **INCLUT**

- Pilule micro dosée par voie orale
- La contraception macroprogestative
orale et injectable;
- les progestatifs administrés par de nouvelles voies :
 - voie sous-cutanée à l'aide d'implants sous-cutanés :
 - voie intra-utérine à l'aide de dispositifs (ou systèmes)

A-PILULE MICRO DOSÉE OU MICROPILULE

- Exemple: Microval (30 $\mu\text{g/j}$ de lévonorgestrel) , Cérazette (75 $\mu\text{g/j}$ de désogestrel)
 - Administrée de façon continue quotidiennement.
 - Prise du cp à une heure fixe
 - Efficacité : indice de Pearl : 0,5 à 2%
 - Avantages : excellente tolérance clinique et biologique, peuvent être utilisée pendant l'allaitement, utilisée en cas de contre indication des OP.
 - Effets secondaires : troubles des règles (aménorrhée, métrorragies anarchiques, spotting) mastodynies.

INDICATIONS:

- Contre indications aux estrogènes
- Intolérance aux estrogènes endogènes
- Période du post partum et de l'allaitement

CONTRE-INDICATIONS

- Post-partum avec allaitement <6 semaines
- Accidents thromboemboliques veineux évolutifs (TVP, EP) (sauf si sous anticoagulants)
- Cardiopathie ischémique
- Accident vasculaire cérébral
- Cancer du sein
- Hépatite virale en évolution
- Cirrhoses décompensées
- Adénomes hépatiques, Hépatomes malins
- Inducteurs enzymatiques

LA CONTRACEPTION **MACROPROGESTATIVE**

C'est la méthode contraceptive de choix pour les patientes en périménopause, puisqu'elle permet en plus de l'action contraceptive, de lutter contre l'hyperoestrogénie relative.

Indication :

- ✓ femme ayant une insuffisance lutéale avec ses conséquences (fibrome, hyperplasie endométriale, mastopathie bénigne, endométriose).
- ✓ Contre-indication aux oestroprogestatifs, avec intolérance aux micro-progestatifs

Par voie orale

le traitement est discontinu (20 jours par mois, du 5^e au 25^e jours du cycle):

Orgametril : 1 à 2 cp/j du 5^e au 25^e jour du cycle

Lutenyl : 1 cp/j du 5^e au 25^e jour du cycle

Injectable

- **Dépoprovéra** 150mg en IM profonde tous les 3 mois.
- Indiquée si : mauvaise observance (pathologie psychiatrique).

CONTRE-INDICATIONS :

- En plus des contre-indications des microprogestatifs:
 - HTA > 16/10
 - hyperlipidémie, obésité
 - diabète

Effets secondaires :

- Prise de poids, rétention hydro-sodée
- troubles des règles (aménorrhée, métrorragies anarchiques)
- Troubles de la minéralisation osseuse (ostéoporose)



Implants sous cutané



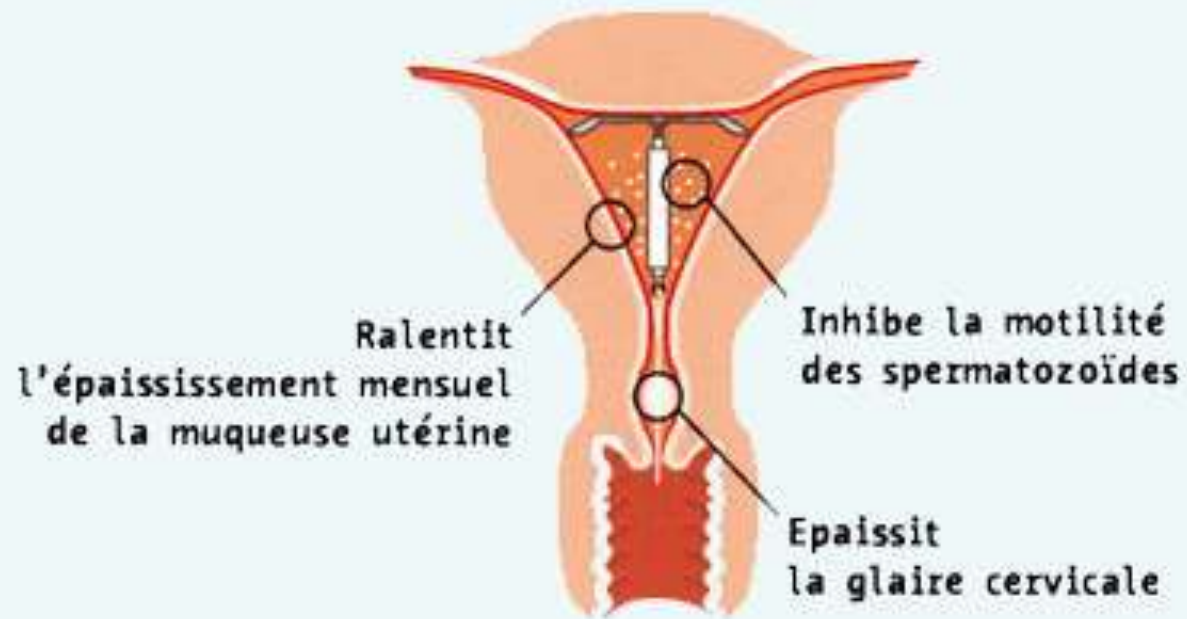


- Un petit bâtonnet souple de 4 cm de long sur 2 millimètres de diamètre contient un dérivé de la progestérone, l'étonogestrel, qui va être délivré en continu.
- **Mode d'utilisation** : insertion sous la peau sur la face interne du bras non dominant, par un médecin pour une **durée de 3 ans**. Il se retire par une incision sous anesthésie locale à l'aide d'une pince.

Contre-indications

- hypersensibilité à l'un des composants
- accident thromboembolique veineux évolutif
- tumeurs malignes, connues ou suspectées
- hémorragies génitales non diagnostiquées
- présence ou d'antécédent d'affection hépatique sévère, tant que les paramètres de la fonction hépatique ne sont pas normalisés
- grossesse connue ou suspectée.
- le cancer du sein

La triple action du stérilet hormonal dans l'utérus:

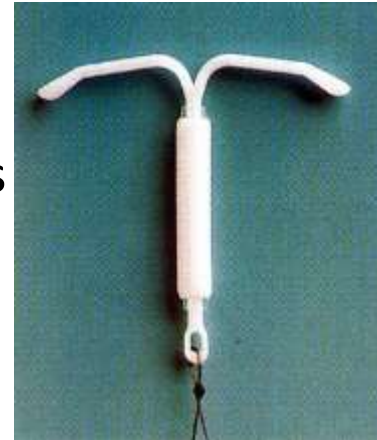


Le
ut

)

Principe et mode d'action:

- Le cuivre est remplacé par un réservoir contenant de la progestérone libérée très progressivement pendant 5 ans.
- Il rend la glaire cervicale opaque, gênant la progression des spermatozoïdes, il crée une atrophie de l'endomètre empêchant une éventuelle nidation.
- le SIU Mirena bénéficie de deux indications :
 - contraception intra-utérine ;
 - ménorragies fonctionnelles (après recherche et élimination de causes organiques décelables).

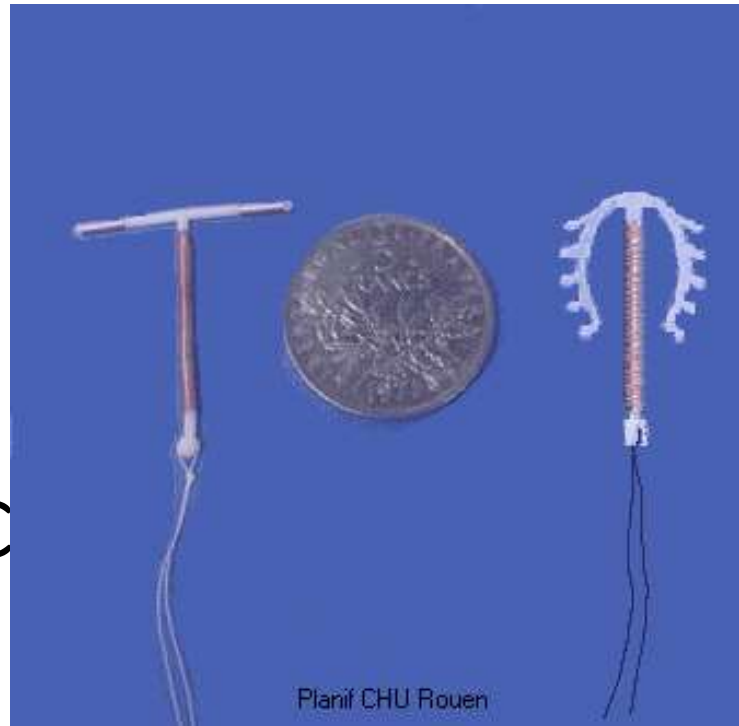


Contre-indications:

- Post-partum < 1 mois
- Infection pelvienne aiguë en évolution, récente ou récidivante
- Malformations utérines
- Fibromes sous-muqueux
- Polypes endo-utérins
- Hémorragies génitales non diagnostiquées
- Cancer génital (ou suspicion)
- Valvulopathies cardiaques à risque d'endocardite
- thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire en cours
- hépatite virale active ; tumeurs hépatiques
- cancer du sein

LA CONTRACEPTION **NON HORMONALE**

Contrace

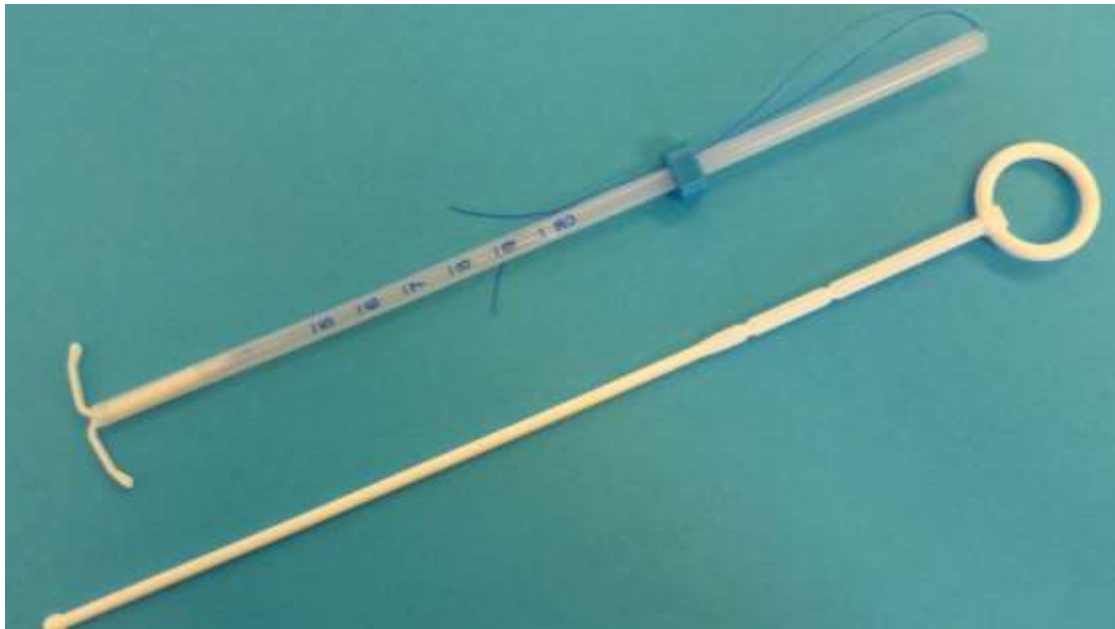


Introduction :

- 2e méthode de contraception en Algérie.
- L'absence de contrainte et d'effets secondaires explique sa bonne acceptabilité.
- 2 complications majeurs sont à craindre : la GEU et l'infection utéro-anexielle qu'il faudra dépister et traiter précocement.

Différents types de stérilets :

- DIU **inerte** : linéaire ou tridimensionnel
- DIU **bioactif** :
 - Au cuivre
 - A la progestérone ou progestatif de synthèse (propriété thérapeutique : ménorragie)



Mode d'action

- -Action antinidation en modifiant l'endomètre par réaction inflammatoire.
- Modification de la glaire cervicale qui devient hostile au déplacement des spz.

Indications :

- contre-indication aux OP et autres méthodes.
- consolidation d'une cure de synéchie.
- Refus de la pilule par la femme ou le couple.
- les femmes désirant éviter le risque d'oublier de prendre régulièrement la pilule

Contre indications Absolues :

- infection génitale aigue.
- Grossesse, antécédent de GEU
- Malformation utérine, fibrome sous muqueux, polype intracavitaire.
- Ménométrorragies de cause non élucidée.
- Cardiopathie valvulaire (risque d'endocardite)
- Nulliparité.
- Coagulopathies

Contre indications relatives :

- haut risque de salpingite.
- Utérus cicatriciel si doute sur la cicatrice.
- Post-partum.
- Traitement anti-inflammatoire au long cours.
- vaginite, cervicite.
- Diabète mal équilibré.

Pose d'un DIU

- Première consultation :
 - Interrogatoire :
 - antécédents gynécologiques : DDR et caractéristiques du cycle, ménorragie, métrorragie, infection génitale, cancer.
 - Antécédent obstétricaux : nombre de grossesse, avortement, accouchement prématuré, BCI, antécédent de GEU, UC,
 - -Examen gynécologique :
 - spéculum : vaginite, cervicite, ectropion infecté, glaire louche.
 - ECB des pertes + AntibioGramme.
 - TV : apprécier l'utérus (taille, position, consistance, sensibilité).
 - Examen des seins.

Pose d'un DIU

- Examens complémentaires :
 - ECB des pertes
 - FCU.
 - FNS, VS si utérus douloureux à la mobilisation.
 - Hystérographie si utérus semble déformé, malformé ou UC.
- Moment de pose :
 - Le DIU doit être posé juste après les règles ; évitant une grossesse.
 - 3 mois après un accouchement, 2 mois après un avortement, 3 à 6 mois après une césarienne.

Technique de pose :

- TV
- Désinfection vaginale soigneuse.
- Hystérométrie (taille et axe de l'utérus)
- Le DIU est introduit en évitant tout contact avec les voies génitales et placé au fond utérin, le fil témoin est coupé à 3cm de l'orifice cervical.
- Antispasmodiques et ATB pendant 5 jours.
- Ne pas faire confiance au DIU pendant le premier cycle

Surveillance :

- prise de la température pendant 2 à 3 jours.
- Examen clinique et échographique.
- FCV tous les ans.

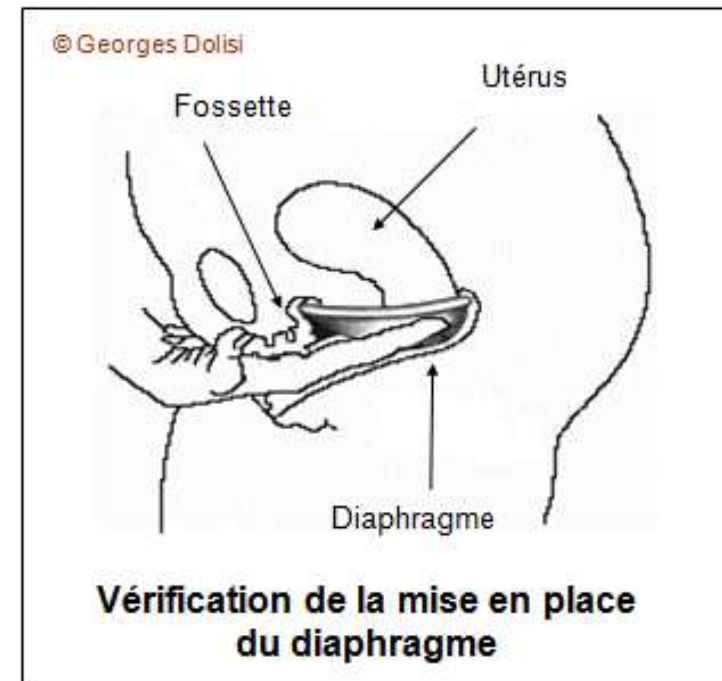
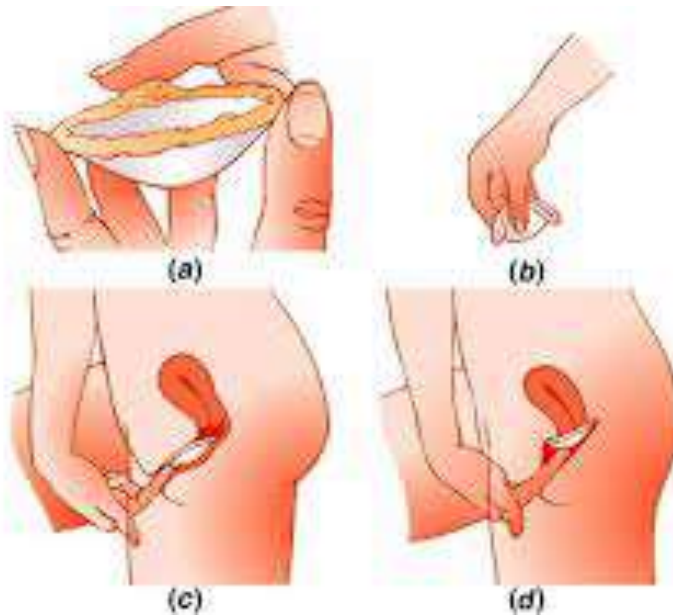
Complications :

- Immédiate:
 - perforation utérine
 - choc vagal, syncope.
 - Douleurs, métrorragies
- Tardives:
 - GEU
 - Grossesse normale accidentelle.
 - Expulsion.
 - Migration.
 - Infection génitale ascendante.

Contraception locale (vaginale)

Le diaphragme

- Dôme en latex placé avant le rapport au fond du vagin, obstrue l'orifice cervical externe
- On l'introduit au plus tôt 6 heures avant le rapport et on l'enlève 6-8 heures après.



Spermicides

- Ovules, crèmes, ou éponges, à mettre dans le vagin avant le rapport sexuel.
- Ils forment une barrière chimique qui détruit les SPZ ou les rend inactifs Efficaces pendant 24 heures
- Ils ne sont généralement utilisés qu'en complément d'autres méthodes (préservatifs, diaphragmes).



Les spermicides

□ AVANTAGES

- Simples d'utilisation
- Sans prescription
- Pas de contre-indications médicales
- Rôle de lubrifiant
- Méthode réversible

□ INCONVÉNIENTS

- Coûteux
- Emploi contraignant
- Possibilité d'intolérance locale
- **20 à 30% d'échec**



Préservatif masculin



- préservatif masculin est disponible en différentes épaisseurs, textures et tailles, en latex ou polyuréthane
- déroulé sur le pénis en érection
- Méthode de choix si partenaires occasionnels ou multiples pour la prévention des IST
- Indiqué surtout si CI à la pilule ou DIU

Le préservatif masculin

□ AVANTAGES

- ▣ La protection contre les MST et le SIDA
- ▣ Méthode simple, facile à se procurer
- ▣ Prise en charge de la contraception par l'homme
- ▣ Protection contre le cancer du col

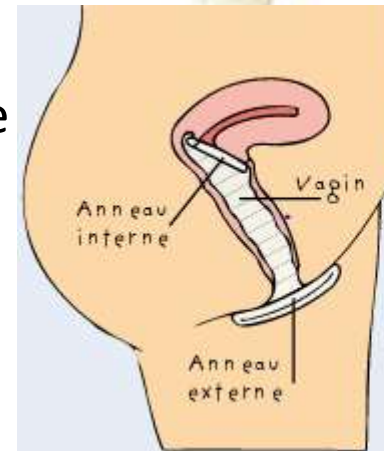
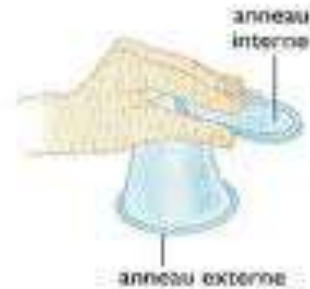
□ INCONVÉNIENTS

- ▣ Peut diminuer la qualité et la spontanéité de l'acte sexuel
- ▣ Peut se déchirer
- ▣ Taux de grossesse non désirée plus important qu'avec la pilule ou le stérilet

Préservatifs féminins (Fémidon)

- Gaine cylindrique prélubrifiée
- L'anneau interne est placé au fond du vagin et l'anneau externe repose au niveau de l'orifice vulvaire
- L'acceptabilité est supérieure à 50 % mais nécessité d'une période d'apprentissage.
- Peut être mis à n'importe quel moment avant le rapport
- Il est adapté aux femmes qui ont une vie sexuelle irrégulière et espacée

Le préservatif est sorti de son étui.



Comment tenir le préservatif féminin de façon à le placer dans le vagin.



Le préservatif féminin



□ AVANTAGES

- Excellente protection contre les MST et le SIDA
- Utilisable par la femme en cas de refus ou d'impossibilité d'utilisation du préservatif masculin

□ INCONVÉNIENTS

- Son prix
- Son installation peut paraître astreignante (surtout chez les jeunes)
- Son aspect peut en décourager certains

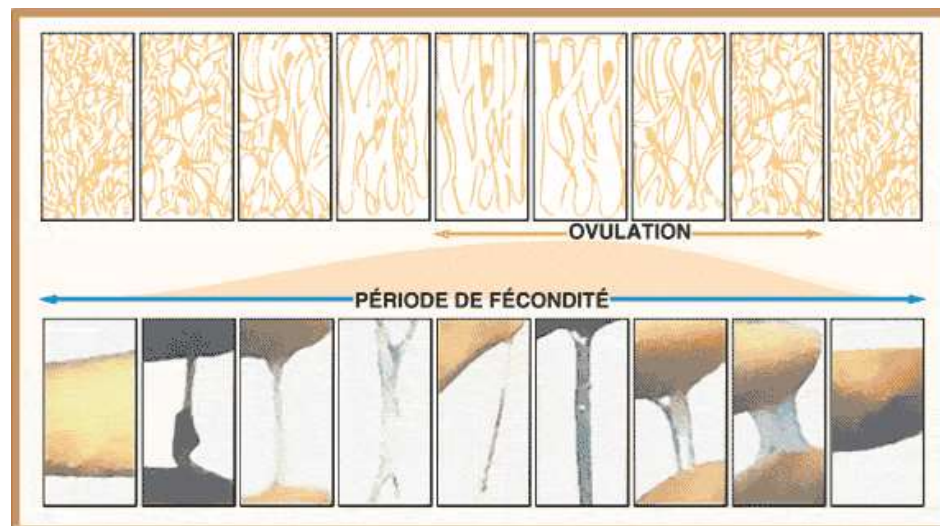
Contraception naturelle

La méthode MAMA

- Cette méthode est utilisable pendant les 6 premiers mois après la naissance ou au moins jusqu'au retour de couches. Toutefois, cette méthode est très contraignante : elle suppose pour être efficace, un allaitement exclusif, À la demande, jour et nuit et l'absence de règles.

Méthode de la glaire cervicale (Billings)

- Abstinence dès l'apparition de la glaire, recherchée par la femme après introduction dans le vagin de 2 doigts puis écartement pour apprécier la filance
- Abstinence à poursuivre 4 jours après l'apparition de la dernière glaire humide.



Coït interrompu (retrait)

- Le taux d'échec est élevé (15 %)
- Cette technique est peu efficace, très astreignante et source de difficultés conjugales

Méthode Ogino-Knauss

- Elle se base sur la durée de vie des spermatozoïdes dans la glaire (3 jours) et sur celle de l'ovule (1 jour)
- Les rapports sexuels sont proscrits du 10^e au 18^e jour d'un cycle de 28 jours
- Elle est inefficace en cas de troubles du cycle car l'ovulation survient à des dates variables

Méthode des températures

- Les rapports sont possibles seulement 2 jours après la montée de la température
- Cette méthode limite les rapports à la période post-ovulatoire, ce qui est astreignant



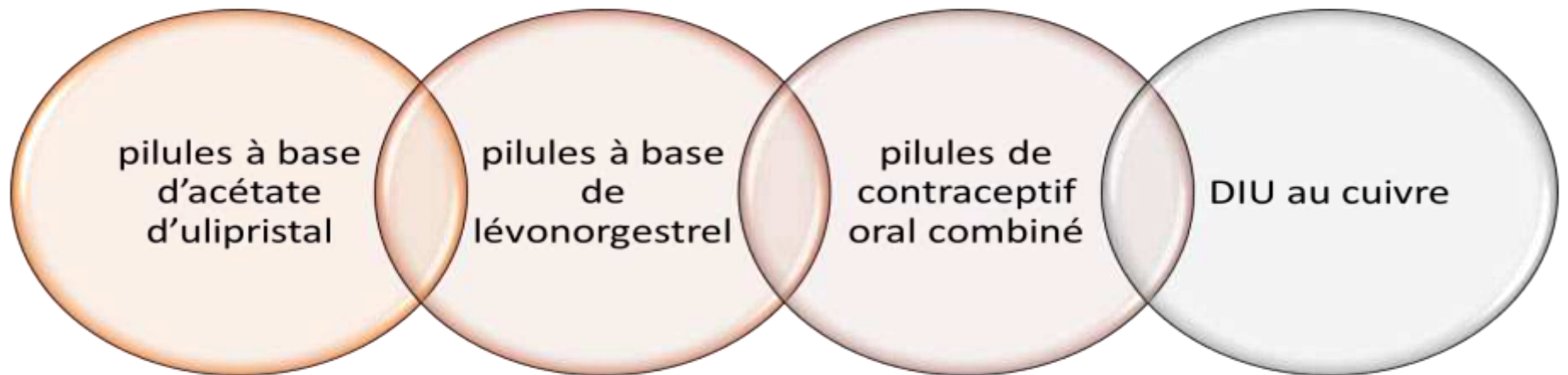
La contraception D'urgence

Définition:

- Contraception du lendemain ou contraception post coïtale.
- C'est une méthode de rattrapage utilisée après un rapport non ou mal protégé (et qui risque d'être fécondant) sans dépasser un délais de 72h après le rapport pour la contraception hormonale.
- La contraception d'urgence n'est pas destinée à substituer la contraception conventionnelle.

Les méthodes

- On dispose de 4 méthodes de CU:



Les méthodes:

- *Norlevo*: un progestatif contenant 1,50 mg de lévonorgestrel: 1 cp à prendre le plus tôt possible et avant 72 h
- *Ellaone* : le principe actif est l'ulipristal 30mg, doit être pris dans les cinq jours qui suivent le rapport sexuel non protégé
- Un oestro-progestative: La première prise de 2 comprimés (au minimum) doit intervenir le plus tôt possible et au plus tard 72 heures, cette première prise est suivie, 12 heures plus tard, de la seconde prise des 2 comprimés restant.
- DIU: Il doit être mis dans les 5 jours après le rapport non protégé, À recommander aux patientes qui envisagent ce mode de contraception pour l'avenir.

NORLEVO® 1,5 mg

Lévonorgestrel

Comprimé unique



CONTRACEPTION MASCULINE

Méthodes contraceptives masculines

```
graph TD; A[Méthodes contraceptives masculines] --> B[Préservatif masculin  
IP = 2%  
IST]; A --> C[Coït interrompu  
IP = 4%]; A --> D[Vasectomie  
IP = 0,2 %]; A --> E[Pilule masculine  
Perspective d'avenir?];
```

Préservatif
masculin

IP = 2%

IST

Coït interrompu

IP = 4%

Vasectomie

IP = 0,2 %

Pilule masculine

Perspective
d'avenir?

PERSPECTIVES EN CONTRACEPTION HORMONALE MASCULINE

- Il faut un délai de **74j** pour inhiber la spermatogénèse; réversibilité = 3 mois environ
- But = inhibition de la production des spermatozoïdes par ↓ FSH et ↓ LH tout en maintenant un taux physiologique d'androgènes
 - Androgènes seuls
 - Associations Progestatifs + androgènes

Stérilisation

Féminine: stérilisation tubaire:

- Intervention irréversible
- Plusieurs méthodes :
 - Hystéroscopie: insertion d'un implant métallique (Essure)
 - Coelioscopie: mise en place de clips ou de YOON ou électrocogulation à la bipolaire
 - Voie vaginale ou laparotomie

Masculine: vasectomie bilatérale:

- ligature et section des canaux déférents sans modifier la fonction endocrine des testicules
- Efficacité après 90 jours
- Repermeabilisation possible mais avec un taux de réussite < 70%

Comment choisir sa
contraception?

Prescription d'une contraception

- La prescription d'une contraception ne se réduit jamais à la simple rédaction d'une ordonnance. Le rôle du médecin c'est d'écouter une demande et souvent susciter une réflexion, parfois, conseiller une méthode, effectuer un bilan médical, organiser une surveillance

Interrogatoire :

- Caractères du cycle menstruel : régularité, abondance des règles, dysménorrhée, syndrome prémenstruel
- Antécédents contraceptifs : nature, tolérance et motifs d'interruption
- Antécédents obstétricaux : gestité, parité, HTA gravidique, cholestase ou prurit gravidique, diabète gestationnel, béance cervico-isthmique, césarienne, salpingite, GEU
- Antécédents médicaux, chirurgicaux et médicamenteux : HTA, thrombose, cardiopathies, varices, inducteurs enzymatiques...
- Habitude : tabagisme, nombre de partenaire
- Antécédents familiaux : maladies cardio-vasculaires ou thromboemboliques, cancers...

Examen clinique :

- Examen somatique complet : tension artérielle, poids, cardio-vasculaire, palpation du foie...
- Palpation des seins, examen gynécologique (spéculum + TV) et Frottis Cervico-Vaginal

Examens complémentaires :

- Selon la méthode, mais dans tous les cas il faut faire un Frottis Cervico-Utérin
 - Pilule OEstro-progestative : bilan métabolique (glucidique et lipidique)
- Ces bilans seront demandés également au cours de la surveillance

En fonction de la période de la vie génitale

- chez l'adolescente la contraception hormonale est la méthode de choix , associé à un préservatif (IST),il s'agit de la COP minidosée
- après 35-40 ans:
 - La Pilule garde une place en l'absence de FDR
 - DIU au progestatif si ménorragies fréquentes

Post- partum:

- - -Microprogestatif à partir du 21eme jour en cas d'allaitement
- toute méthode est possible après 2mois si absence d'allaitement

Post-abortionum:

- La contraception pourra être démarrée immédiatement de préférence par une pilule séquentielle

- Diabète:
 - DIU possible si pas d'antécédents infectieux gynécologiques
 - OP possible si diabète insulino-dépendant bien équilibré sans complications oculaires

Conclusion: